

Struktura przed ilością — *fundament wczesnej fazy*

3 posiłki + 2–3 przekąski, co 3–4 godziny, bez przerwy >4h. Cel: regularność, nie liczby. Bez tego CBT-E traci skuteczność.

CZAS: 30 min psychoedukacji + plan **REALIZACJA:** sesje 2–4 CBT-E, przed każdą inną interwencją

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, *Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders*, rozdz. 7); Fairburn i in. (2013, *Behav Res Ther*); Waller i in. (2007); NICE (2017, NG69)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **pięć mechanizmów**, dlaczego regularne jedzenie działa w AN (i dlaczego jest *fundamentem*, nie „jedną z technik”). Sekcja 02 — **osiem kroków implementacji**: od psychoedukacji do oczekiwanego dyskomfortu pierwszych 2–3 tygodni. Sekcja 03 — **plan posiłków** do wypełnienia z pacjentem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Regularne jedzenie w CBT-E AN to **fundament wczesnej fazy**, nie „jedna z technik”. Schemat 3+2+1: 3 posiłki + 2–3 przekąski + ewentualna 1 wieczorna, co 3–4 godziny, bez przerw >4h. *Najpierw struktura, później ilości* — liczenie kalorii jest przeciwwskazane (wzmacnia nadwartościowanie). Fairburn (2008): regularne jedzenie odpowiada za większą część zmian we wczesnej fazie CBT-E niż wszystkie późniejsze techniki poznawcze. Pierwsze 2–3 tyg. są trudne — to normalne.

01 Pięć mechanizmów — dlaczego regularne jedzenie działa

MECHANIZM

CO SIĘ DZIEJE FIZJOLOGICZNIE I POZNAWCZO

1 · Normalizacja głodu i sytości	Przewlekła restrykcja zaburza peptydy regulacyjne (ghrelina, leptyna, CCK). Regularne jedzenie odbudowuje sygnały — pacjent zaczyna czuć <i>realny</i> głód i <i>realną</i> sytość, nie wyłącznie lęk lub poczucie obowiązku.
2 · Przerwanie cyklu restrykcja → napady	Przerwy między posiłkami >4h zwiększają ryzyko utraty kontroli (subiektywne lub obiektywne napady). 3+2+1 zapobiega temu strukturalnie. Polivy i Herman (1985): <i>restrained eating</i> predysponuje do <i>disinhibition</i> .
3 · Spadek zaprzątnięcia myśli jedzeniem	Paradoksalnie: <i>im częściej</i> pacjent je, <i>tym mniej</i> myśli o jedzeniu. Obsesje jedzeniowe są <i>biologiczną odpowiedzią</i> na głód, nie cechą osobowości (Keys i in., 1950).
4 · Budowa tolerancji (habitualizacja)	Każdy posiłek to <i>mini-ekspozycja</i> na lęk przed jedzeniem i sytością. Powtarzanie wygasza lęk (mechanizm habituacji). Bez regularności — brak ekspozycji.
5 · Stabilizacja glikemii	Częste, równomiernie rozłożone posiłki stabilizują poziom glukozy → poprawa nastroju, koncentracji, energii poznawczej. Bez tego CBT-E poznawcza traci skuteczność.

Najpierw struktura, później ilości. Nie mów pacjentowi „jedz 2000 kcal” — to wzmacnia nadwartościowanie liczb. Mów: „jedz pięć razy dziennie cokolwiek”. Ilości wprowadzamy po 2–3 tygodniach strukturalnych — i nawet wtedy nie w kaloriach, lecz w opisie posiłków.

1. **Psychoedukacja** — „Regularne jedzenie to fundament zdrowienia. Ciało potrzebuje przewidywalności. Głodzenie + napady + głodzenie destabilizuje metabolizm i psychikę. 3 posiłki + 2-3 przekąski, co 3-4h, to struktura, do której wracamy”.
2. **Wyjaśnij mechanizm** — „Im częściej jesz, tym mniej myślisz o jedzeniu. Brzmi paradoksalnie? Tak działa ciało — obsesja jedzeniowa to biologiczna odpowiedź na głód. Odżywianie = ciszej w głowie”.
3. **Ustal plan razem z pacjentem** — konkretne godziny posiłków. Przykład: śniadanie 8:00, przekąska 10:30, obiad 13:00, przekąska 16:00, kolacja 19:00 (opcjonalnie przekąska 21:00). Godziny stałe, nie ruchome.
4. **Cztery zasady niepodlegające negocjacji:** (a) posiłki w stałych godzinach, nawet jeśli pacjent „nie jest głodny/-a”; (b) nie pomijaj posiłków — nawet niewielki jest lepszy niż żaden; (c) nie „nadrabiaj” pominiętego posiłku następnym — to wzmacnia zaburzenie; (d) przerwa między posiłkami nie > 4h.
5. **Najpierw struktura, później ilości** — nie mów „jedz 2000 kcal”. Mów: „jedz 5 razy dziennie cokolwiek”. Ilości wprowadzamy stopniowo po 2-3 tygodniach strukturalnych — opisowo, nie w kaloriach.
6. **Monitorowanie (dziennik jedzeniowy)** — co i kiedy, nie kalorie (CBT-E nie używa liczenia). Format: godzina, opis posiłku, krótki komentarz (głód, sytość, trudność). Przegląd na każdej sesji.
7. **Rozwiązywanie przeszkód** — „Co może uniemożliwić Ci jedzenie regularnie? Szkoła? Praca? Brak przygotowania? Lęk? Opór „głosu AN”?” Plan dla każdej przeszkody — konkretne strategie (przygotowanie z wieczora, sygnalizatory czasu, wsparcie bliskich).
8. **Oczekuj dyskomfortu — 2-3 tygodnie** — „Pierwsze 2-3 tygodnie będą trudne: napięcie, wstyd, lęk przed sytością. To normalne. Po 3 tygodniach regularnego jedzenia zauważysz: mniejsze obsesje, lepsza koncentracja, więcej energii”. Normalizacja dyskomfortu = warunek wytrwania.

ŚNIADANIE — GODZINA

— stała, niezależna od głodu; bez „pomijania” nawet w trudny dzień

PRZEKĄSKA I — GODZINA

— między śniadaniem a obiadem, około 2,5–3,5h po śniadaniu

OBIAD — GODZINA

— stała; jeśli to godzina pracy, plan musi to uwzględniać (z domu, w pracy, restauracja)

PRZEKĄSKA II — GODZINA

— między obiadem a kolacją; często najbardziej omijana, ważne by ją zachować

KOLACJA — GODZINA

— stała; nie później niż 2h przed snem dla wygody, ale jedz nawet jeśli późno

PRZEKĄSKA WIECZORNA (OPCJONALNIE) — GODZINA

— +1 jeśli kolacja wcześniej lub gdy przerwa do snu >3h

TRZY PRZESZKODY, KTÓRYCH OCZEKUJĘ, I JAK JE ROZWIĄŻĘ

— np. „w pracy nie mam czasu” → przygotowuję przekąski z wieczora

Klucz: regularne jedzenie 3+2+1 nie jest negocjowalne. „Głos AN” pacjenta będzie próbował podważać każdą zasadę („a może mogę tylko 3 razy?”, „a jeśli nie jestem głodny/-a?”, „a jeśli zjem trochę później?”). To nie jest racjonalny dialog — to opór strukturalny AN. Rolą klinicysty jest trzymać strukturę, dopóki pacjent nie jest stabilny. Fairburn (2008): regularne jedzenie to jeden z nielicznych obszarów CBT-E, w którym nie ma elastyczności. Negocjacja zasad = osłabienie fundamentu = osłabienie całej terapii. **Komunikat:** „Nie negocjujemy czy jeść 5 razy. Negocjujemy tylko co i jak”.

⚠ **Refeeding syndrome:** u pacjenta z BMI <14 lub po długiej restrykcji wprowadzanie regularnego jedzenia wymaga koordynacji z lekarzem (kontrola fosforanów, potasu, magnezu, ciśnienia, EKG). 3+2+1 jako strukturę wprowadzamy, ale ilości ustala dietetyk we współpracy z lekarzem. Patrz karta refeeding syndrome.